

FICHA TÉCNICA PSICOMÉTRICA

INVENTARIO DE ANSIEDAD DE BECK (BAI)

Eje I: Problemas, Síntomas y Riesgo • Evaluación de Síntomas Somáticos y Cognitivos de Ansiedad

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL INSTRUMENTO

Nombre Oficial (Español)	Inventario de Ansiedad de Beck (BAI).
Nombre Original (Inglés)	<i>Beck Anxiety Inventory (BAI)</i>
Autores Originales	Drs. Aaron T. Beck, Norman Epstein, Gary Brown y Robert A. Steer (1988).
Adaptación Española	Sanz & Navarro (2003); Sanz, Navarro & Vázquez (2003); Sanz (2011).
Eje Clínico y Clasificación	Eje I: Problemas, Síntomas y Riesgo. Discriminación específica de ansiedad frente a depresión.
Tipo de Instrumento	Autoinforme de 21 reactivos con escala Likert de 4 puntos (0 a 3).
Población Diana	Adolescentes (>= 13 años) y adultos en población clínica psiquiátrica y general.
Tiempo de Administración	5 a 10 minutos en autoadministración.
Régimen de Licencia	Instrumento protegido (The Psychological Corporation / Pearson). Versión de investigación clínica libre.

2. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL Y DISCRIMINACIÓN DE LA DEPRESIÓN

El BAI fue construido deliberadamente por Beck y colaboradores para subsanar la alta correlación y el solapamiento de constructo que presentaban las escalas de ansiedad tradicionales (como el STAI o el MAS) con las medidas de depresión. Mediante análisis factoriales iterativos, se seleccionaron aquellos síntomas clínicos que mostraban una asociación diferencial primaria con los trastornos de ansiedad, minimizando reactivos de afecto negativo general.

Como resultado, el BAI otorga un peso preponderante a los **síntomas fisiológicos y vegetativos de activación autónoma** (palpitaciones, sudoración, temblor, mareos) y a los **síntomas subjetivo-cognitivos de pánico y vulnerabilidad física** (miedo a morir, perder el control o volverse loco). Esta arquitectura refleja fielmente la hiperactivación del sistema nervioso simpático y de las estructuras troncoencefálicas (locus coeruleus) que caracterizan las respuestas fóbicas y de crisis de angustia.

3. ESTRUCTURA FACTORIAL Y COMPOSICIÓN DE ÍTEMS

Factor Clínico	Ítems	Rango Dir.	Contenido Fenomenológico y Semiológico
1. Subescala Somática	14 ítems	0 a 42	Entumecimiento/hormigueo (1), acaloramiento (2), temblor de piernas (3), mareo (5), palpitaciones (6), inestabilidad (7), sofoco (9), temblor de manos (11), opresión torácica (12), falta de aire (15), atragantamiento (17), sudoración (18), calor o frío facial (20) y sudores fríos (21).
2. Subescala Cognitiva / Pánico	7 ítems	0 a 21	Incapacidad para relajarse (4), miedo a que suceda lo peor (8), terror o pánico (10), miedo a perder el control (13), miedo a morir (14), asustado/sobresaltado (16) y náuseas/malestar digestivo (19).
PUNTUACIÓN TOTAL	1 al 21	0 a 63	Índice global de reactividad ansiosa somatovegetativa y cognitiva.

PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS, BAREMOS Y CORRECCIÓN

4. VALIDEZ, CONFIABILIDAD Y RENDIMIENTO DIAGNÓSTICO EN ESPAÑA

Consistencia Interna	Excelente confiabilidad en muestras clínicas y generales españolas: alfa de Cronbach de 0.90 a 0.93 (Sanz & Navarro, 2003; Magán et al., 2008).
Estabilidad Temporal	Confiabilidad test-retest $r = 0.75$ tras una semana en pacientes ambulatorios con trastorno de ansiedad.
Validez Discriminante	Discriminación nítida frente al BDI-II (correlación $r = 0.50$ a 0.58), significativamente menor que la compartida entre el STAI y el BDI ($r > 0.75$).
Validez Convergente	Correlaciones moderadas a altas con la Escala de Ansiedad de Hamilton (HAM-A $r = 0.60$) y con medidas de fobia social y agorafobia.
Estructura Bifactorial	Confirmación del modelo jerárquico bifactorial (dimensión general de ansiedad + factores específicos somático y subjetivo).

5. REGLAS DE CORRECCIÓN Y CÁLCULO DE PUNTUACIONES

El sujeto califica la intensidad con la que le ha molestado cada síntoma durante la **última semana (incluido el día de hoy)**:

- **0** = En absoluto | **1** = Levemente (no me molestó mucho) | **2** = Moderadamente (fue muy desagradable pero pude soportarlo) | **3** = Severamente (casi no pude soportarlo).
- **Puntuación Total:** Suma de todos los ítems puntuados de 0 a 3. Rango global: **0 a 63 puntos**.
- **Subescalas:** Somática (suma de los 14 reactivos físicos; máx 42) y Cognitiva (suma de los 7 reactivos de temor/pánico; máx 21).

6. ESTRATIFICACIÓN CLÍNICA Y PUNTOS DE CORTE (SANZ, 2011)

Nivel	Rango	Estado Clínico	Interpretación y Manejo
Mínimo	0 a 7	Nivel normal de ansiedad	Puntuaciones esperables en población no clínica. Ausencia de activación neurovegetativa perturbadora.
Leve	8 a 15	Ansiedad subclínica o reactiva	Hiperreactividad somática ligera o contextual. Valorar estresores ambientales; psicoeducación.
Moderado	16 a 25	Ansiedad clínica significativa	Presencia notable de sintomatología física y cognitiva. Sugiere trastorno de pánico, fobia específica o agorafobia. Requiere psicoterapia.
Grave	26 a 63	Ansiedad severa e incapacitante	Crisis de angustia frecuentes, somatización masiva y sensación de terror/catástrofe inminente. Tratamiento combinado urgente.

UTILIDAD DIAGNÓSTICA EN EL TRASTORNO DE PÁNICO: El BAI es especialmente sensible a la sintomatología del Trastorno de Pánico y la Agorafobia debido al elevado peso de ítems autonómicos cardiorrespiratorios (ítems 6, 12, 15, 17) y temores catastróficos (ítems 13 y 14).

APLICACIÓN CLÍNICA, CASO ILUSTRATIVO Y REFERENCIAS

7. ALGORITMO CLÍNICO Y DISCRIMINACIÓN PERFILAR

DISCRIMINACIÓN FENOMENOLÓGICA ENTRE BAI Y BDI-II: • **Perfil BAI Alto / BDI-II Bajo:** Trastorno de angustia, fobia social o estrés agudo puro. La intervención debe priorizar exposición interoceptiva y desactivación fisiológica. • **Perfil BAI Bajo / BDI-II Alto:** Depresión melancólica o anhedonia sin componente ansioso comórbido. Intervención en activación conductual y ritmos circadianos. • **Perfil Mixto BAI Alto / BDI-II Alto:** Depresión ansiosa grave. Mayor riesgo de resistencia terapéutica y conductas impulsivas autolíticas.

8. CASO CLÍNICO ILUSTRATIVO: CRISIS DE ANGUSTIA Y AGORAFOBIA

Paciente: Mujer de 28 años, abogada, que acude a consulta tras dos visitas al servicio de urgencias por crisis de palpitaciones súbitas, mareo y sensación de asfixia en el transporte público, con exploraciones cardiológicas normales. Presenta conductas de evitación de trenes y centros comerciales. **Puntuación BAI Total: 29 puntos (Nivel Grave de Ansiedad).** • **Desglose factorial:** Subescala Somática = 20 pts (palpitaciones = 3, falta de aire = 3, mareo = 3, temblor = 3, sofocos = 2, sudoración = 2, opresión = 2, inestabilidad = 2); Subescala Cognitiva = 9 pts (miedo a morir = 3, miedo a perder el control = 3, terror = 2, incapaz de relajarse = 1). BDI-II concurrente = 7 (mínimo). **Conducta Asistencial:** Diagnóstico de Trastorno de Pánico con Agorafobia incipiente. Se inicia TCC protocolizada basada en el modelo de Clark (psicoeducación del círculo de la ansiedad, reestructuración de interpretaciones catastróficas de síntomas corporales y exposición interoceptiva a hiperventilación y giros). A las 8 semanas, el BAI disminuye a 8 puntos (reducción del 72%), permitiendo la normalización del uso del transporte público sin conductas de escape.

9. ALERTAS DE SEGURIDAD Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL SOMÁTICO

ALERTA: SÍNTOMAS CARDIOVASCULARES En pacientes de edad madura o con factores de riesgo vascular que puntúen alto en opresión torácica (ítem 12) o disnea (ítem 15), es mandatorio realizar descartar de enfermedad coronaria antes de atribuirlo a etiología ansiosa.

SÍNTOMAS NEUROLÓGICOS Entumecimiento o parestias unilaterales (ítem 1) exigen diagnóstico diferencial neurológico para descartar patología cerebrovascular o neuropatías compresivas periféricas.

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS CIENTÍFICAS

1. Beck, A. T., Epstein, N., Brown, G., & Steer, R. A. (1988). An inventory for measuring clinical anxiety: Psychometric properties. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 56(6), 893–897.
2. Sanz, J., & Navarro, M. E. (2003). Propiedades psicométricas de una versión española del Inventario de Ansiedad de Beck (BAI) en estudiantes universitarios. *Ansiedad y Estrés*, 9(1), 59–84.
3. Sanz, J. (2011). Recomendaciones para la utilización de la adaptación española del Inventario de Ansiedad de Beck (BAI) en la práctica clínica. *Clínica y Salud*, 25(1), 39–48.
4. Magán, I., Sanz, J., & García-Vera, M. P. (2008). Psychometric properties of a Spanish version of the Beck Anxiety Inventory (BAI) in general population. *The Spanish Journal of Psychology*, 11(2), 626–640.